

Entirillado Electrónico

(P. del S. 692) Conferencia

LEY

Para enmendar el inciso (g) del Artículo 3 de la Ley 156-2006, según enmendada, conocida como “Ley de Acompañamiento durante el Trabajo de Parto, Nacimiento y Post-parto”, a los fines de extender el derecho de acompañamiento a toda evaluación en sala de emergencias relacionada al embarazo, independientemente de si ha comenzado el proceso de parto; ordenar al Departamento de Salud a establecer un Protocolo uniforme; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 156-2006, según enmendada, conocida como “Ley de Acompañamiento durante el Trabajo de Parto, Nacimiento y Post-parto”, reconoce el derecho de toda mujer embarazada a estar acompañada durante el trabajo de parto, nacimiento y postparto inmediato. No obstante, cientos de mujeres gestantes acuden cada año a las salas de emergencia por complicaciones, molestias o episodios de preocupación que pueden no representar un inicio de parto inmediato, pero que sí constituyen eventos de emergencia obstétrica o evaluación crítica.

Durante este proceso, muchas mujeres son ubicadas en salas de observación o evaluación gineco-obstétrica y permanecen solas por largas horas, sin ~~que puedan solicitar~~ el apoyo emocional de un acompañante, lo que genera ansiedad, estrés y sensación de abandono, incluso en momentos de miedo por la salud del feto o de ellas mismas.

Ampliar el derecho de acompañamiento ~~la solicitud de la mujer embarazada,~~ desde la llegada al hospital en cualquier escenario de emergencia relacionada al embarazo, sin limitarlo al inicio formal del trabajo de parto, garantiza un trato digno, empático y respetuoso con la salud emocional y física de la mujer gestante, y está en armonía con recomendaciones internacionales de salud perinatal.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el inciso (g) del Artículo 3 de la Ley 156-2006, según enmendada, conocida como “Ley de Acompañamiento durante el Trabajo de Parto, Nacimiento y Post-parto”, para que lea como sigue:

“Artículo 3.-

Toda mujer embarazada, durante su embarazo y al momento del trabajo del parto, el parto y el post-parto, tendrá los siguientes derechos:

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

e) ...

f) ...

g) A estar acompañada por personas de su confianza y elección durante el trabajo de parto, en las salas de preparto, en el parto y postparto, incluyendo el procedimiento de cesárea, en el cual podrá estar acompañada por al menos una persona de su elección; entendiéndose, sin embargo que la presencia de la(el) acompañante o acompañantes no podrá interferir con las determinaciones de carácter médico que consideren o tomen los profesionales de la salud con responsabilidad en el parto, y en caso del procedimiento de cesárea, serán éstos los que determinarán en última instancia si permiten o no la presencia del acompañante. Además, ~~a su solicitud~~, tendrá derecho a no estar acompañada, si así lo desea la mujer. Asimismo, tendrá derecho a estar acompañada por una persona de su elección, desde el momento de su llegada a cualquier institución hospitalaria, ya sea pública o privada, cuando acuda por una situación de emergencia, evaluación o sospecha de complicación relacionada con su embarazo, incluyendo, pero sin limitarse a sangrados, dolor, pérdida de líquido, contracciones, falta de movimiento fetal, hipertensión, entre otros. Este derecho incluye las etapas de observación o evaluación en sala de emergencias, unidades de triage o salas gineco-obstétricas, y se extenderá durante todo el trabajo de parto, parto y postparto inmediato. Este derecho, ~~en caso de haber sido solicitado por~~ de la mujer embarazada, solo podrá ser restringido por razones estrictamente médicas, de seguridad institucional, las cuales deberán constar por escrito en el expediente médico o debido a situaciones extraordinarias como lo son emergencias de salud pública, epidemias o desastres naturales donde la presencia del acompañante podrá ser suspendida temporariamente. Disponiéndose que el acompañante vendrá obligado a cumplir con aquellas reglas que tuviere a bien imponer la institución hospitalaria, siempre y cuando dichas reglas sean cónsonas a lo establecido en esta Ley.

h) ...

i) ...

j) ...

k) ...

l) ... "

Sección 2.- Protocolo Uniforme

El Departamento de Salud deberá establecer un Protocolo Uniforme para garantizar el cumplimiento y la aplicación consistente de esta Ley, en un término de ciento veinte (120) días desde su aprobación. El Protocolo deberá definir: los espacios permitidos para el acompañamiento, las excepciones clínicas y de seguridad, los límites físicos y de participación del acompañante, guías de actuación ante la suspensión temporal del derecho por situaciones extraordinarias, las guías de control de infecciones aplicables a escenarios de epidemias o emergencias de salud pública, la capacitación del personal médico y de enfermería sobre el manejo de acompañantes en escenarios obstétricos, y la armonización de sus disposiciones con la reglamentación vigente del Departamento de Salud y con los estándares de las entidades acreditadoras aplicables, entre otros. Asimismo, el Departamento de Salud orientará y brindará apoyo técnico a las instituciones hospitalarias, en especial a las del sector público y a las de la zona rural con limitaciones de espacio, para lograr la implementación equitativa de esta Ley.

Sección 3.- Separabilidad.

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de esta Ley fuere anulada o declarada inconstitucional, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de esta que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

Sección 4.- Vigencia.

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.